

DERMATITIS ATÓPICA

Camila 9 años

Desde los 4 años presenta lesiones cutáneas que han sido interpretadas como impétigo recidivante. Camila, y su madre, refieren intenso prurito que le dificulta el sueño y altera su rendimiento escolar. La niña dice que no quiere hacer deportes porque el sudor le aumenta el prurito; tampoco quiere participar de eventos sociales con sus compañeros del colegio porque no quiere que vean las lesiones de su piel.



Al examen dermatológico presenta placas eritematosas, especialmente localizadas en miembros superiores e inferiores. Con signos de rasgado crónico e hiperpigmentación residual. (Ver QR Fig. 1, 2 y 3).

- ¿Coincide con el diagnóstico de impétigo recidivante?
- ¿Qué diagnósticos diferenciales se podrían plantear?

OBJETIVOS

- ◆ Considerar a la dermatitis atópica como una de las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes en niños y adolescentes.
- ◆ Identificar las diferentes formas de presentación de la enfermedad en niños y adolescentes.
- ◆ Incorporar el concepto de Dermatitis Atópica como enfermedad sistémica y definir el rol del pediatra en el diagnóstico precoz y manejo de sus comorbilidades.
- ◆ Evaluar el impacto de la enfermedad en cada paciente.
- ◆ Reflexionar acerca de los errores más frecuentes en el abordaje y tratamiento de la enfermedad.
- ◆ Promover los cuidados diarios de la piel y el uso adecuado de tratamientos específicos.
- ◆ Considerar la derivación oportuna al especialista y fomentar el manejo interdisciplinario.

INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica y recidivante que afecta la piel, es inmunomediada y multifactorial. Puede preceder o estar asociada al desarrollo de otros trastornos atópicos, como asma, conjuntivitis, rinitis alérgica, y alergias alimentarias.

Clínicamente se caracteriza por la presencia de piel seca, prurito y el desarrollo de eccemas, que presentan una distribución característica.

Su síntoma predominante es el prurito, que produce un gran impacto en la vida del individuo que la padece. En la actualidad, se la considera una patología sistémica. La dermatitis atópica es una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes del ser humano. En muchos casos la enfermedad comienza en la infancia y afecta a los pacientes solo durante los primeros años de vida pero en otros, sobre todo en los más severos, persiste toda la vida. Algunos individuos desarrollan la enfermedad recién en la edad adulta. Su incidencia se encuentra en aumento, posiblemente asociada a los cambios en el estilo de vida occidental, como el aumento de la edad materna al nacimiento, la polución ambiental, el tabaquismo, los hábitos higiénicos y la reducción de la lactancia materna, entre otros.

¿Cuál es la incidencia de la Dermatitis Atópica? La incidencia es de aproximadamente 10 al 20% en niños y del 5% en adultos. Esto varía de acuerdo a la región geográfica y la etnia. Generalmente comienza en la niñez, el 65% de los casos se presentan durante el primer año de vida y hasta el 90% antes de los cinco años de edad. Entre el 1-3% de los pacientes pueden tener las primeras manifestaciones de la enfermedad recién en la edad adulta.

¿Cuál es su causa? La patogénesis de la enfermedad es multifactorial, e involucra una compleja interacción entre factores genéticos, medioambientales y psicosociales.

Se caracteriza por la presencia de una alteración en la respuesta inmunológica, tanto innata como adaptativa, acompañada de defectos en la función de barrera de la piel, los cuales permiten mayor pérdida transepidérmica de agua, incremento en la permeabilidad a irritantes y alérgenos ambientales y aumento en la susceptibilidad a las infecciones cutáneas.

El modelo inmunopatogénico inicial atribuía la enfermedad al desbalance entre la respuesta inmunológica mediada por linfocitos T helper (Th2 vs. Th1). En la actualidad, se considera que la fisiopatogenia es más compleja e involucra anomalías en la función de la barrera cutánea, además de factores inmunológicos, que incluyen no solo la cascada inflamatoria relacionada con los linfocitos Th2 y la producción de Interleucinas (IL-4, IL-5 e IL-13), sino también la actividad de otras poblaciones linfocitarias, como los linfocitos Th17 y los Th22, junto con las citoquinas asociadas a su actividad, como las IL-17, IL-22, que promueven la inflamación y proliferación celular a través de su acción sobre los queratinocitos, y de la IL-31, principal responsable del prurito en esta patología.

Por otro lado, los **defectos en la función de barrera** se originan en el déficit de varios de sus componentes debido a mutaciones en los genes responsables de su producción, como los de la filagrina (proteína fundamental para la adecuada formación de la barrera cutánea), también es de destacar la disfunción de las uniones estrechas y otras proteínas que forman parte de esta barrera, así como la cantidad y proporción inadecuada de los lípidos que la forman, en especial las ceramidas, lo que favorece una alteración en su permeabilidad selectiva. La inflamación es en parte, también responsable, de la producción inadecuada de los componentes de la barrera cutánea.

¿Cómo influyen los factores ambientales en la dermatitis atópica? Además de las alteraciones genéticas, que dan lugar a la alteración de la función inmune y de barrera cutánea, es necesaria la presencia de desencadenantes que favorezcan su aparición. Los gatillos más conocidos son

los alérgenos, como ácaros, polvo, polen, alimentos, fibras sintéticas, prendas de lana, sudor, luz solar, infecciones, entre otros.

Muchos pacientes pueden también tener asma alérgica, alergias alimentarias, otras alergias y/o rinitis.

Además, factores no inmunitarios como el estrés, la ansiedad y otras emociones negativas también pueden agravar la dermatitis atópica, lo mismo que los cambios bruscos de temperatura y las temperaturas extremas.

¿Cómo se diagnostica la dermatitis atópica? ¿Es necesario solicitar estudios de laboratorio?

El diagnóstico de la dermatitis atópica continúa siendo clínico, a través de los criterios diagnósticos. Los más utilizados son los de Hanifin y Rajka, redactados en el Simposio Internacional de Dermatitis Atópica en Oslo en 1979, publicados en 1980. Toman en cuenta 4 criterios mayores (de los cuales se necesitan 3) y 23 criterios menores (se requieren 3 presentes) (ver Tabla 1). Muchos de estos criterios menores describen las lesiones clínicas características de la enfermedad. También existen otras opciones de criterios diagnósticos enunciadas por sociedades científicas dermatológicas.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka

Criterios mayores (3 de 4)	Criterios menores (3 de 23)
Prurito Morfología y distribución característica de las lesiones Dermatitis crónica o recidivante Historia personal o familiar de atopía	Xerosis Ictiosis/Hiperlinealidad palmar/queratosis pilar Reactividad inmediata (tipo 1) a tests cutáneos IgE elevada Edad de comienzo precoz Tendencia a infecciones cutáneas/Defectos de inmunidad mediada por células Dermatitis inespecífica de manos y pies Eccema del pezón Queilitis Conjuntivitis recurrente Pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan Queratocono Catarata subcapsular anterior Oscurecimiento orbitario Eritema/palidez facial Pitiriasis alba Pliegues anteriores del cuello Prurito al transpirar Intolerancia a la lana y los solventes de lípidos Acentuación perifolicular Intolerancia a los alimentos Curso influenciado por factores ambientales/emocionales Dermografismo blanco/blanqueo retardado

Fuente: Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de la Dermatitis Atópica 2019. SAD – AAAeIC

Los estudios complementarios como biopsia de piel, estudios de laboratorio o test de parches, son de utilidad para descartar otros diagnósticos diferenciales o patologías asociadas, pero no certifican el diagnóstico de Dermatitis Atópica.

¿Es la dermatitis atópica una enfermedad alérgica? Como ya se mencionó, el origen de la dermatitis atópica es multifactorial. Con un componente inmunológico y con la alteración de la función de la barrera cutánea que puede generar la sensibilización frente a algunos alérgenos. Pero no siempre está presente esta sensibilización.

Los alérgenos más relacionados con la misma son los aeroalérgenos, que pueden promover reacciones eccematosas en pacientes sensibilizados con dermatitis atópica. Esto puede explicarse por la mayor permeabilidad de la barrera cutánea para los alérgenos y, por otra parte, por la presencia de IgE específica asociada a las exacerbaciones estacionales por pólenes, en particular de gramíneas, y test de parche positivos a los alérgenos de interiores, como los ácaros (*Dermatophagoides pteronyssinus*, *Dermatophagoides farinae*), muy abundantes en los dormitorios y la ropa de cama. Las evidencias en favor del beneficio de las estrategias de evitación son controvertidas, con estudios que muestran una marcada mejoría y otros, con resultados no tan alentadores. Los epitelios animales, en particular del gato, se asocian a mayor riesgo, pero el contacto con perros desde la infancia aparenta ser protector, probablemente por la exposición a microorganismos y toxinas que favorecen un desvío de la inmunidad en favor de las células T regulatorias. Sin embargo, si el paciente está ya sensibilizado, se sugiere evitar el contacto.

La presencia de alergia alimentaria se ha demostrado en algunos niños con dermatitis atópica moderada a severa, pero no en todos, por lo tanto, en la mayoría de los niños no se recomiendan las dietas restrictivas.

¿Cómo se presenta la dermatitis atópica? Los eccemas suelen mostrar una distribución relacionada con la edad. Los lactantes (≤ 2 años) muestran lesiones agudas, caracterizadas por pápulas y placas, eritematosas surcadas por vesículas, a menudo asociadas con exudado seroso y costras. Por lo general afectan la cara, el tronco, las superficies extensoras de la extremidad y, en ocasiones, la zona del pañal. En la infancia (a partir de los dos años de edad), se caracteriza por la aparición de piel seca, eritema pápulas y placas, algunas liquenificadas, que afectan las superficies flexoras, especialmente huecos poplíteos y antecubitales, también las manos y los pies. La afectación facial es menos prominente, pero cuando está presente, puede aparecer una enfermedad perioral, y se observa distribución periorbitaria.

Desde el año a los dos años de edad en adelante se observan manifestaciones polimorfas con diferentes tipos de lesiones cutáneas tales como eczema numular o variantes morfológicas que incluyen el tipo folicular caracterizado por pápulas foliculares densamente agregadas.

Los adolescentes y adultos suelen presentar pápulas y placas simétricas, a menudo asociadas con liquenificación y excoriaciones. Las áreas de la piel predominantemente involucradas son las regiones de flexión, la cara, el cuello y las extremidades distales. Además, en adolescentes y adultos, la afectación de la mano, el pezón o el párpado son más frecuentes. En adolescentes, además de las

zonas antes descritas, existen otras posibles presentaciones como la dermatitis en retrato, que afecta cara, cuello y tronco superior, el eccema difuso con eritema y descamación generalizados, el eczema numular, en forma de monedas, y el prurigo nodular. La eritrodermia puede observarse hasta en el 0,7% de los pacientes.

¿Por qué se considera a la dermatitis atópica una enfermedad sistémica? Porque está asociada a procesos extracutáneos vinculados con la atopia como el asma, la rinoconjuntivitis alérgica, la alergia a alimentos y la esofagitis eosinofílica y a condiciones extracutáneas como afectación de la salud mental, con cuadros de depresión y ansiedad y mayor riesgo de suicidio. Otras comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y óseas están siendo objeto de estudio y ya en diversas series se ha informado mayor frecuencia de estas patologías en pacientes atópicos. Enfermedades inmunomediadas como la alopecia areata, el vitíligo, la urticaria crónica y la artritis reumatoidea también se consideran más frecuentes en esta población.

Los pacientes con dermatitis atópica presentan con mayor frecuencia insatisfacción con su calidad de vida y limitaciones en su estilo de vida, interacciones sociales y actividades debido a la carga de su enfermedad. Experimentan tristeza, aislamiento, estigmatización, ansiedad y culpa. La ansiedad y la depresión son más frecuentes, especialmente en aquellos con la enfermedad mal controlada. Se desconocen los mecanismos exactos de asociación entre la dermatitis atópica y los trastornos de salud mental pero los síntomas de la dermatitis atópica tales como la picazón, las alteraciones del sueño, la neuroinflamación, el aislamiento social y la estigmatización podrían ser factores contribuyentes.

El impacto psicosocial de la dermatitis atópica también se extiende a los cuidadores, que sienten preocupación por la recurrencia y la persistencia de la enfermedad de su hijo y los efectos adversos de los tratamientos. Muchos informaron pérdida de sueño o disminución de la calidad del sueño, notando efectos negativos en la concentración y el desempeño laboral, el estado de ánimo y niveles de energía, además de importantes sentimientos de culpa.

Los adolescentes con dermatitis atópica tienen una mayor prevalencia y frecuencia de sufrir acoso en comparación con aquellos que no la padecen. Los niños con enfermedades de la piel sufren discriminación relacionada con síntomas visibles, tienen menos amistades y menor participación escolar y extracurricular que sus pares. Es un grupo más vulnerable al consumo de sustancias ilegales y alcoholismo.

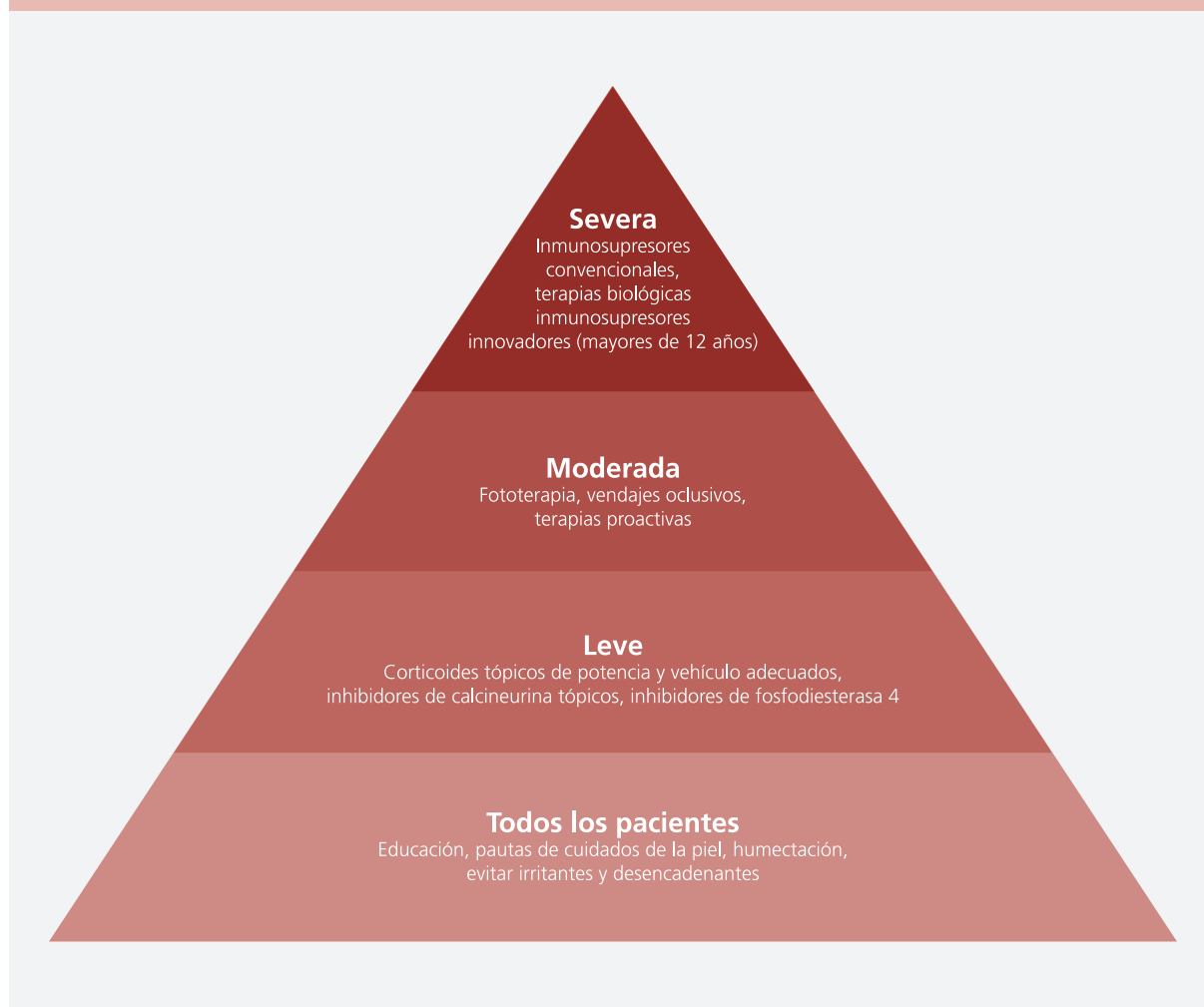
En esta población, también se encuentran con mayor frecuencia déficit de atención e hiperactividad, patologías del espectro autista y convulsiones. Existen publicaciones que relacionan estas patologías con la actividad aumentada de IL-4 y otros trabajos muestran que el control de la enfermedad bloqueando esta interleuquina mejora la evolución de estas comorbilidades.

Otro eje de estudio es la baja talla y peso que presentan muchos niños con dermatitis atópica moderada a severa. Esto ha sido relacionado con la alteración del sueño. Cuando los niños no duermen en forma correcta, no tienen REM (Rapid Eyes Movement) de duración y frecuencia adecuadas. Durante el REM es cuando se produce hormona de crecimiento. El déficit de esta hormona

sería también responsable de la osteoporosis, osteopenia y mayor frecuencia de fracturas en esta población. Todo esto hace que sea indispensable evaluar al paciente en forma interdisciplinaria, detectando en forma precoz las comorbilidades e interviniendo en forma oportuna para mejorar su evolución.

¿Cuál es el mejor tratamiento para la dermatitis atópica? La respuesta es simple: es aquel que controle sus signos y síntomas, por lo tanto, no puede ser el mismo para todos los pacientes. Lamentablemente muchos pacientes con enfermedad moderada a severa no reciben el tratamiento acorde a la gravedad de su enfermedad. **Los objetivos del tratamiento de la dermatitis atópica son reducir el prurito, restablecer la función de la barrera cutánea, normalizar la disbiosis de la piel y eliminar la inflamación que se observa en los eccemas** de modo de establecer un control de la enfermedad que sea suficiente para que los pacientes puedan llevar una vida normal y funcional en su hogar, estudios y trabajo. Estos objetivos requieren una aproximación escalonada y progresiva adecuada a la severidad (ver Figura 4).

Figura 4. Tratamiento escalonado de la Dermatitis Atópica



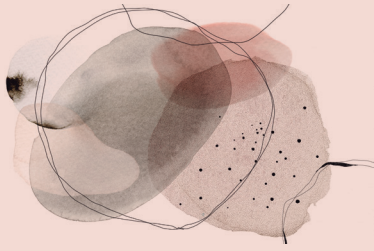
Fuente: Modificado y actualizado de Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de la Dermatitis Atópica 2019. SAD - AAAeIC

La enfermedad puede presentarse en forma leve, fácilmente tratable con cuidados diarios, humectación y terapias tópicas, o puede ser moderada a severa en cuyo caso requiere de estrategias terapéuticas más complejas e incluso de terapias sistémicas. Un análisis reciente encontró una prevalencia de dermatitis atópica severa en aproximadamente el 8% de los niños entre 6 y 11 años de edad. Por esta razón los pediatras debemos poder detectar a estos pacientes para realizar el trabajo interdisciplinario y terapéutico adecuado que mejore y controle la evolución de la enfermedad. El abordaje terapéutico debe incluir estrategias a corto y largo plazo. Para mejorar el cumplimiento es importante que los médicos tratantes sean sensibles a la ansiedad de los padres y pacientes sobre la enfermedad y a los posibles efectos adversos reales o percibidos de los tratamientos disponibles.

El tratamiento correcto se logra a través de educar a los pacientes y sus familias sobre la dermatitis atópica como una enfermedad compleja y crónica, que requiere de un cuidado particular de la piel que es la piedra angular del tratamiento. Utilizando productos de higiene adecuados, que respeten el pH de la piel, baños cortos, con frecuencia acorde a la edad del paciente, clima y situaciones culturales. **El uso de emolientes y humectantes después del baño es fundamental para restaurar y conservar la función de barrera de la piel.**

En los niños que presentan exacerbaciones de su eccema, es necesario instaurar tratamientos específicos. Los más indicados son los tópicos, como los corticoides y los inhibidores de la calcineurina (como el pimecrolimus y tacrolimus). Actualmente también se encuentran disponible el crisaborol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Estos medicamentos pueden ser utilizados en forma reactiva, frente a cada brote hasta controlar el mismo o en forma proactiva, cambiando la frecuencia de su aplicación a lo mínimo necesario para controlar la inflamación subclínica.

En pacientes con enfermedad moderada a severa, es necesario escalar el tratamiento. De acuerdo a la edad de los pacientes, a la extensión, localización y severidad de la enfermedad pueden utilizarse fototerapia, inmunosupresores sistémicos convencionales, como el metotrexate, la ciclosporina o azatioprina, terapias innovadoras como inhibidores de JAK (upadacitinib y abrocitinib) a partir de los 12 años de vida; o terapias biológicas, como dupilumab, actualmente aprobado a partir de los 6 meses de vida.



Autoevaluación

II. Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es verdadero y F si es Falso.

V F

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. La dermatitis atópica es una enfermedad alérgica. | ☐ | ☐ |
| 2. La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recidivante | ☐ | ☐ |
| 3. Se considera que la dermatitis atópica es una enfermedad sistémica porque está asociada a procesos extracutáneos. | ☐ | ☐ |
| 4. La incidencia de la enfermedad varía según la etnia de la población y las condiciones del ambiente | ☐ | ☐ |
| 5. Se ha publicado recientemente que la prevalencia de dermatitis atópica severa, en niños entre 6 y 11 años, es del 8% aproximadamente. | ☐ | ☐ |
| 6. En todos los casos la enfermedad comienza en los primeros años de vida | ☐ | ☐ |
| 7. Los objetivos del tratamiento de la dermatitis atópica es reducir el prurito y restablecer la función de la barrera cutánea. | ☐ | ☐ |
| 8. Para restablecer la función de barrera cutánea se debe evitar el uso de cremas corporales. | ☐ | ☐ |
| 9. El diagnóstico de la enfermedad se basa fundamentalmente en los antecedentes familiares. | ☐ | ☐ |
| 10. Además de las alteraciones genética que dan lugar a la alteración de la función inmune y de barrera cutánea, es necesaria la presencia de desencadenantes que favorezcan la aparición de la enfermedad. | ☐ | ☐ |

III. Ciertas condiciones actúan como "gatillos" que desencadenan la enfermedad. Mencione por lo menos 3 "gatillos."

.....

PSORIASIS

Federico, 16 años.

Antecedente de obesidad, hipercolesterolemia e hipertensión arterial, en seguimiento y tratamiento por cardiología infantil. Desde los 8 años presenta lesiones en placas eritematosa-escamosas en codos, rodillas, dorso de manos, zona retroauricular y cuero cabelludo. Ha sido tratado con cremas con antibióticos y corticoides pero las lesiones persisten y con el curso de los años se han ido presentando el resto de los hallazgos clínicos. (Ver QR Fig. 4, 5 y 6). **¿Cuál es la conducta a seguir?**

OBJETIVOS

- ◆ Considerar a la psoriasis como enfermedad dermatológica frecuente en niños y adolescentes.
- ◆ Identificar las diferentes formas de presentación de la enfermedad en niños y adolescentes y sus diagnósticos diferenciales.
- ◆ Incorporar el concepto de Psoriasis como enfermedad sistémica y definir el rol del pediatra en el diagnóstico precoz y manejo de sus comorbilidades.
- ◆ Evaluar el impacto de la enfermedad en cada paciente.
- ◆ Reflexionar acerca de los errores más frecuentes en el abordaje y tratamiento de la enfermedad.
- ◆ Promover los cuidados diarios de la piel y el uso adecuado de tratamientos específicos para psoriasis.
- ◆ Considerar la derivación oportuna al especialista y facilitar el manejo interdisciplinario.

INTRODUCCIÓN

La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, inmunomediada, multisistémica, que afecta la piel. Las lesiones cutáneas son a menudo el motivo de consulta médica.

Suele presentar un curso recurrente y puede afectar negativamente la calidad de vida de los niños y sus familias. **En la psoriasis de aparición temprana, existe una fuerte tendencia de predisposición genética.** Las lesiones de psoriasis a menudo se confunden con las del eczema porque ambos son enfermedades crónicas que presentan piel enrojecida y escamosa, lo que sugiere que la verdadera prevalencia de psoriasis pediátrica puede ser aún mayor de la que se conoce en la actualidad. El reconocimiento de la afección como un trastorno potencialmente multisistémico es

importante para optimizar el tratamiento de la enfermedad. La intervención temprana en la psoriasis pediátrica puede reducir el impacto y la carga de la enfermedad y posiblemente sus comorbilidades, lo que enfatiza la necesidad de un diagnóstico preciso y temprano de esta enfermedad en los niños y adolescentes.

¿Cuál es la frecuencia de la psoriasis en pacientes pediátricos?

La psoriasis afecta aproximadamente al 1% de los pacientes en edad pediátrica. La edad promedio de aparición de psoriasis es entre los 8 y 11 años y la prevalencia aumenta con la edad, se estima en el 0,13% en los menores de 2 años y el 0,67% en adolescentes. Un tercio de los pacientes con psoriasis en la edad adulta, presentaron los primeros síntomas antes de los 20 años.

Representa el 4% de la consulta a médicos especialistas en Dermatología infantil.

¿Cuál es su causa? Se trata de una enfermedad multifactorial, en la cual existe una predisposición genética, dada por la presencia de mutaciones en diversos genes y la presencia de desencadenantes o gatillos. En su etiología participan tanto la inmunidad innata como la adquirida. Las células involucradas son los linfocitos T helper, las células dendríticas y natural killer (NK). Las interleuquinas (IL) sintetizadas por las células dendríticas van a determinar la diferenciación de los linfocitos T vírgenes a T helper (Th), y la consecuente producción de diversas interleuquinas. Frente a un ambiente donde predomina la síntesis de IL-12, la diferenciación será a un perfil Th1 con aumento de los niveles de interferón gamma (INF- γ), IL-2, factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), IL-6 e IL-1. Si, en cambio, predomina la síntesis de IL-23, el viraje se produce hacia un perfil Th17, donde predomina la síntesis de IL-17 y de IL-22. Estas citoquinas estimulan la proliferación de los queratinocitos, que se manifiesta clínicamente como hiperqueratosis y median la inflamación a nivel dérmico.

En la actualidad, se reconoce al eje IL23-Th17-IL17 como el involucrado preferencialmente en la patogenia de la psoriasis. Sobre esta predisposición genética actúan diversos gatillos.

¿Cuáles son los gatillos de la enfermedad? En la infancia existen múltiples factores desencadenantes. Las infecciones, en particular la faringitis y la dermatitis estreptocócicas perianal se han relacionado con la aparición y el empeoramiento de la enfermedad. El trauma también puede actuar como desencadenante, tanto en el lugar de la lesión (fenómeno de Koebner) como en sitios distantes. Con menor frecuencia en los niños, el estrés asociado con la escuela, el nacimiento de un hermano o la separación de los padres pueden también favorecer su aparición. El uso de algunos medicamentos sistémicos es menos frecuente en los niños pero los antipalúdicos, antiinflamatorios no esteroideos y la suspensión brusca de corticosteroides sistémicos pueden gatillar la enfermedad.

¿Es fácil diagnosticar psoriasis en pediatría? No siempre es fácil diagnosticar la enfermedad. El diagnóstico se basa principalmente en el reconocimiento de las lesiones clínicas características. Los hallazgos cutáneos clásicos en la psoriasis son placas eritematosas con escamas de color blanco plateado que afectan con mayor frecuencia las rodillas, los codos, el cuero cabelludo, la zona posterior de los pabellones auriculares, el ombligo y la cara. La afectación anogenital es común en este grupo etario. Las lesiones pueden ser asintomáticas, pero en niños es frecuente que pre-

senten prurito. Rara vez es necesaria una biopsia de piel pero puede resultar útil especialmente en pacientes con presentaciones atípicas. Una historia familiar positiva puede ayudar en casos sospechosos de psoriasis ya que la enfermedad de inicio infantil presenta una mayor frecuencia de psoriasis en familiares de primer y segundo grado.

¿Cómo se presenta la psoriasis? Las lesiones clásicas de la enfermedad son placas eritematoescamosas claramente circunscritas.

La psoriasis en placas es la forma de presentación más común. Se observa en el 69% al 75% de los casos pediátricos. Estas lesiones generalmente afectan el cuero cabelludo, los codos y las rodillas, pero pueden encontrarse en cualquier localización. El compromiso retroauricular y del ombligo aumentan la sospecha de esta enfermedad. El compromiso facial es característico de la infancia y puede ser la única localización de la enfermedad hasta en el 4% de los casos pediátricos.

La psoriasis guttata o en gotas es el segundo grupo más común, reportada en el 14% al 29% de los casos pediátricos. La infección estreptocócica es un desencadenante bien reconocido de psoriasis guttata, que puede desaparecer después de tratar la infección con antibióticos.

Otras formas de presentación incluyen el compromiso de palmas y plantas, psoriasis palmoplantar; el de pliegues, psoriasis invertida, que se presenta como placas bien delimitadas, de color rosado a rojo, a menudo maceradas, en los pliegues axilar, inguinal y glúteo. El compromiso de la zona del pañal tiene estas características, debido a la maceración de las lesiones por el uso de los pañales. Existen formas de presentación menos frecuentes, como la psoriasis pustulosa en la que se observan como lesión elemental pústulas sobre las placas eritematosas. Esta forma puede ser localizada, generalizada o anular subaguda; esta última, más frecuente en niños que en adultos. La eritrodermia por psoriasis es poco frecuente, pero debe ser considerada dentro de los diagnósticos diferenciales de eritrodermia en la infancia, especialmente frente a gatillos como la suspensión brusca de corticoides sistémicos. Más recientemente se ha incluido una forma lineal de la enfermedad, que afecta principalmente ciertas zonas de la piel siguiendo las líneas de Blaschko (líneas imaginarias que aparecen por una alteración de la migración celular).

La afectación de las uñas ocurre en el 17-39% de los casos y puede ser un signo de un curso más prolongado. Clínicamente se observa alteración de la lámina y del lecho ungueal, con lesiones características como el pitting (uña en dedal), leuconiquia (manchas blanquecinas en las uñas), onicomadesis (despegamiento de la lámina), manchas de aceite e hiperqueratosis subungueal.

¿Qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta? El diagnóstico de psoriasis pediátrica puede ser un desafío para los pediatras ya que las lesiones pueden parecer similares a las del eccema, la tiña u otras afecciones inflamatorias de la piel, como el eccema seborreico, más conocidas en la práctica diaria. En la zona del pañal es importante considerar este diagnóstico diferencial cuando las lesiones no resuelven a pesar del adecuado tratamiento de una dermatitis irritativa o moniliásica.

Dermatitis atópica El diagnóstico diferencial por excelencia es la dermatitis atópica en la que el eccema suele ser más prominente en las fosas antecubital y poplítea, áreas flexoras de las mu-

Forma clínica	Característica
Psoriasis en placas	Placas eritematoescamosas
Psoriasis Guttata	Pequeñas placas eritematoescamosas generalizadas (puede desaparecer después de tratar la infección con antibióticos)
Psoriasis invertida	Placas eritematosas, sin escamas, localizadas en pliegues axilar inguinal y glúteo (zona del pañal)
Psoriasis ungueal	Puede ser la presentación inicial de la enfermedad. Marcador de riesgo de compromiso articular. Frecuencia: 17-39%
Psoriasis palmoplantar	Puede ser la única localización de la enfermedad
Psoriasis pustulosa • Localizada • Generalizada • Anular subaguda	Presencia de pústulas sobre las placas eritematosas
Psoriasis eritrodérmica	Compromiso de más del 90% de la superficie corporal, con afectación del estado general. Frecuentemente asociada a la suspensión de corticoides sistémicos
Psoriasis lineal	Poco frecuente, las lesiones siguen líneas de Blaschko

ñecas y las caras dorsales de las manos, mientras que las lesiones de psoriasis comúnmente se localizan en el cuero cabelludo, las palmas, las plantas y las superficies extensoras de los codos y las rodillas. Además, el eccema típicamente respeta el área del pañal y los pliegues cutáneos, mientras que la psoriasis comúnmente afecta estas áreas. La afectación de las uñas es otra característica de la psoriasis pediátrica que puede respaldar la diferenciación del eccema. La biopsia de piel puede ayudar a distinguir la psoriasis pediátrica de otras afecciones de la piel, pero no siempre es concluyente. Las características histológicas diagnósticas incluyen engrosamiento epidérmico con alargamiento de la red de crestas, hipergranulosis y paraqueratosis.

Tiñas. Luego del eccema, el gran diagnóstico diferencial son las tiñas. Las infecciones micóticas pueden afectar zona de pliegues, uñas o presentarse como placas de borde circinado, lo que representa un diagnóstico diferencial para múltiples formas de psoriasis.

Pitiriasis rubra pilaris. También es un desafío diagnóstico, si bien es poco frecuente, sus lesiones pueden simular lesiones de psoriasis. Incluso en algunos casos tienen aspectos genéticos en común.

La psoriasis guttata, tiene como diagnósticos diferenciales la pitiriasis rosada de Gibert, la pitiriasis liquenoide crónica y el liquen plano.

En las formas invertidas de la psoriasis, uno de los diagnósticos diferenciales a esta edad es la histiocitosis de células de Langerhans, por tener localizaciones en común, como la zona del pañal, pliegues axilares y cuero cabelludo. Si bien en ambas entidades puede observarse eritema y escamas seborreicas, en la histiocitosis se agrega una infiltración característica de la piel y la presencia de petequias.

La psoriasis es considerada en la actualidad una enfermedad autoinflamatoria, por esta razón, enfermedades autoinflamatorias como el DIRA (La deficiencia del antagonista del receptor de la IL-1) y el DITRA (síndrome de deficiencia del antagonista del IL-36R) pueden ser consideradas diagnósticos diferenciales o parte del espectro de presentación de la enfermedad.

¿Cuáles son las comorbilidades que pueden acompañar a la psoriasis? Las comorbilidades extracutáneas asociadas con la psoriasis pediátrica pueden contribuir a la carga física y psicosocial de la enfermedad y pueden afectar negativamente la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Los pacientes con esta enfermedad tienen mayor riesgo de artritis, uveítis, enfermedad inflamatoria intestinal, asma bronquial, hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, hiperlipidemia, hipertensión arterial, obesidad, diabetes y síndrome metabólico. El síndrome metabólico se observa con mayor frecuencia que en pacientes sin esta enfermedad, lo que sugiere que la Psoriasis es un factor de riesgo independiente para desarrollar comorbilidades metabólicas. La psoriasis también puede coexistir con vitiligo, alopecia areata y liquen plano, lo que complica aún más el diagnóstico y tratamiento.

La artritis psoriásica representa aproximadamente del 6% al 8% de todos los casos pediátricos de artritis inflamatoria.

En el 80% de los niños con artritis psoriásica, la inflamación de las articulaciones se desarrolla antes de la aparición de la enfermedad de la piel, generalmente 2 a 3 años antes de dicha afectación. Aunque puede ocurrir en niños de cualquier edad, los dos rangos de edad más comunes para el compromiso de las articulaciones son de 2 a 3 años y 10 a 12 años.

Los pacientes pediátricos con artritis psoriásica tienen síntomas típicos asociados con la artritis inflamatoria, que incluye dolor articular, hinchazón de las articulaciones y rigidez en reposo o al despertar. Los niños más pequeños, en particular las niñas, tienden a presentar enfermedad oligoarticular y/o dactilitis. Los niños mayores, particularmente los varones, tienden a presentar entesitis y afectación de las articulaciones axiales.

También pueden presentar uveítis, la prevalencia varía ampliamente entre 1,5% -25%. La uveítis se ha identificado sólo en pacientes con artritis concomitante y no en aquellos con psoriasis limitada a la piel.

Los pacientes con psoriasis también tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar artritis reumatoide, presumiblemente debido a mecanismos inmunológicos similares.

Tanto la obesidad como la psoriasis causan inflamación sistémica a través de la regulación positiva de las células Th 1 y Th 17; por lo tanto, cada condición exacerba a la otra.

La obesidad en pacientes con psoriasis tiende a ser obesidad central (percentilo de circunferencia de cintura aumentada respecto al percentilo de índice de talla y peso) y suele desarrollarse alrededor de los 8 años.

La prevalencia estimada de dislipidemia en pacientes con psoriasis pediátrica según los datos disponibles es aproximadamente el doble que la de los niños sin psoriasis.

Los pacientes con psoriasis pediátrica con obesidad tienen más probabilidades de tener dislipidemia en comparación con los pacientes con psoriasis pediátrica que tienen peso normal, pero puede estar presente en ellos también.

La tasa de prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes de 0 a 20 años en relación con individuos control no afectados es del 0,51% versus 0,14% para la enfermedad de Crohn (tasa de prevalencia, 3,69; IC del 95%: 2,15-6,35) y 0,12% versus 0,10% para colitis ulcerosa (tasa de prevalencia 1,13; IC 95% 0,38-3,31). Por esta razón, se recomienda realizar pruebas de detección de enfermedad inflamatoria intestinal si los pacientes tienen síntomas gastrointestinales, crecimiento deficiente o pérdida de peso involuntaria.

¿Cuál es el impacto de la enfermedad en los niños y sus familias? Tener una enfermedad cutánea visible es muy estresante para los niños. La psoriasis tiene tanto impacto en la calidad de vida del paciente como la diabetes, la epilepsia y la dermatitis atópica. Un estudio en pacientes con psoriasis pediátrica mostró que el 65% experimentó estigmatización en forma de intimidación, insultos y vergüenza.

Esta estigmatización puede resultar en cambios de comportamiento, depresión, ansiedad y conductas de riesgo.

El riesgo de desarrollo de depresión después del inicio de la psoriasis es mayor al de niños sin la enfermedad. Dichos pacientes también tenían un mayor riesgo de abuso de alcohol, abuso de drogas, trastornos alimentarios, uso de benzodiazepinas y medicamentos antipsicóticos.

También sus padres y familiares pueden verse afectados por esta condición.

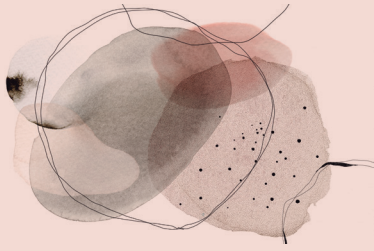
¿Cómo es el manejo actual de la enfermedad? Las opciones de tratamiento disponibles y actualmente recomendadas son medicamentos tópicos, fototerapia, retinoides orales, inmunosupresores y agentes biológicos. La mayoría de los pacientes con psoriasis se benefician del uso de tratamientos tópicos. Los corticosteroides tópicos se utilizan como primera línea para niños con psoriasis leve a moderada. Pueden asociarse a análogos de la vitamina D, como el calcipotriol, y a ácido salicílico o coaltar. Debe tenerse en cuenta el vehículo y potencia de los corticoides según el sitio a tratar.

En pacientes con una superficie corporal afectada mayor al 10% o que no responden en forma adecuada al tratamiento tópico, es necesario escalar el tratamiento. La fototerapia UV-B de banda angosta es un tratamiento eficaz, su uso en niños está limitado por la necesidad de visitas al consultorio de 2 a 3 días por semana y la cercanía a los centros donde se realiza dicha terapia. Para pacientes con una respuesta inadecuada a los tratamientos tópicos o con comorbilidades adicionales, se pueden utilizar agentes inmunosupresores orales, como metotrexato o ciclosporina, o retinoides sistémicos, como isotretinoína o acitretin. Los niños con compromiso extenso, o que afecte sitios difíciles de tratar, con gran impacto en la calidad de vida, como el cuero cabelludo, la cara, la ingle, las palmas, las plantas y las uñas, o presenten artritis psoriásica juvenil o tengan contraindicaciones para agentes orales convencionales, son candidatos para el tratamiento con un agente biológico. Los productos biológicos para uso pediátrico aprobados en distintos países

incluyen a los inhibidores del Factor de necrosis tumoral (etanercept y adalimumab), anti IL-12/23 (ustekinumab) y anti IL-17A (ixekizumab y secukinumab). En nuestro país se encuentran aprobados etanercept, adalimumab y secukinumab. El uso de estos medicamentos es de resorte del médico especialista, pero deben ser conocidos por el pediatra, quien tiene un rol fundamental en el manejo interdisciplinario y el acompañamiento del niño y su familia.

¿Cuál es el rol del pediatra en el tratamiento? ¿Cuándo derivar al especialista? La psoriasis en niños y adolescentes debe ser tratada de acuerdo con su severidad y al impacto que la misma tenga en la salud y calidad de vida de quienes la padecen.

El pediatra como médico de cabecera de niños y adolescentes tiene un rol fundamental en el diagnóstico de la enfermedad y la detección temprana de las comorbilidades. En los pacientes con enfermedad leve, puede comenzar el tratamiento tópico, y realizar la derivación oportuna al médico especialista. En los pacientes con enfermedad moderada a severa, que requieren terapias sistémicas, su rápida derivación y trabajo conjunto con los dermatólogos modifican la carga de la enfermedad y sus comorbilidades, y le ofrece a estos niños la oportunidad de llevar adelante el desarrollo pleno de sus capacidades evitando la carga acumulada de la enfermedad.



Autoevaluación

IV. Utilice las siguientes palabras para completar las oraciones para que sean afirmaciones correctas. Cada palabra puede ser usada una, varias o ninguna vez.

artritis – articulaciones- aumenta -codos – corticosteroides tópicos - cuero cabelludo- dendríticas- depresión- dermatitis atópica - diferenciación- disminuye- eczema- eritematoes-camosas-estreptocócica- gatillos- genética. 8-10 años- inmunomoduladores- mutaciones - ombligo- palmas – plantas- plateado – retinoides- retroauricular- rodillas - vitíligo- sistémicos-3- 5 años-

1. Las lesiones de psoriasis a menudo se confunden con las del..... porque ambos son enfermedades crónicas que presentan piel enrojecida y escamosa.
2. La edad promedio de aparición de psoriasis es entre los
3. La prevalencia de psoriasiscon la edad.
4. En la enfermedad psoriasis, existe una predisposición genética, dada por la presencia deen diversos genes, y acción de factores desencadenantes o gatillos.
5. Las células involucradas son los linfocitos T helper, las célulasy natural killer (NK).
6. Las interleuquinas (IL) sintetizadas por las células dendríticas van a determinar lade los linfocitos T vírgenes a T helper (Th) y la consecuente producción de diversas interleuquinas.
7. La faringitisse ha relacionado con la aparición y el empeoramiento de la psoriasis.
8. La brusca suspensión de corticoidespueden gatillar la enfermedad.
9. Los hallazgos cutáneos clásicos en la psoriasis son placas eritematosas con escamas de color blancoque afectan con mayor frecuencia las rodillas, los codos, el cuero cabelludo, la zona posterior de los pabellones auriculares, ely la cara.

10. El compromiso del áreay delaumentan la sospecha de esta enfermedad.
11. Las lesiones clásicas de la enfermedad son placas claramente circunscritas.
12. El diagnóstico diferencial por excelencia es la en la que el eczema suele ser más prominente en las fosas antecubital y poplítea, áreas flexoras de las muñecas y las caras dorsales de las manos, mientras que las lesiones de psoriasis comúnmente se localizan en el las, las y las superficies extensoras de los y las
13. La psoriasis también puede coexistir con, alopecia areata y liquen plano, lo que complica aún más el diagnóstico y tratamiento.
14. En el 80% de los niños con psoriásica, la inflamación de las se desarrolla entre 2 y 3 años antes de la aparición de la enfermedad de la piel.
15. El riesgo de desarrollar después del inicio de la psoriasis es mayor que el de los niños sin la enfermedad.
16. Los se utilizan como primera línea para niños con psoriasis leve a moderada.
17. Para pacientes con una respuesta inadecuada a los tratamientos tópicos o con comorbilidades adicionales se pueden utilizar agentesorales o sistémicos.

Compare sus respuestas con las que figuran en la CLAVE DE RESPUESTAS.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Establezca la correspondencia.

Establezca la correspondencia entre los insectos y arácnidos que figuran en la columna de la izquierda y los enunciados de la columna de la derecha. Coloque la letra que corresponda en cada insecto. Cada letra puede ser usada una, varias o ninguna vez.

Escorpión a- d- - f- g- h- i	a) El emponzoñamiento causa dolor inmediato. b) El momento de la picadura puede pasar inadvertido. c) Su picadura puede matar por envenenamiento masivo y/o por anafilaxia a los componentes del veneno. d) El veneno inyectado estimula las glándulas suprarrenales y los sistemas simpático y parasimpático liberando acetilcolina, adrenalina y noradrenalina.
Arañas Del rincón b - e - h - j Viuda negra e - h - l Del banano e - h	e) Ataca cuando se siente amenazada. f) Los vómitos reiterados son signo premonitorio de gravedad. g) Manifestaciones sistémicas pueden aparecer a los pocos minutos después de la picadura y hasta 2 horas más tarde. h) Su veneno puede llegar a matar.
Abejas c - k	i) Administrar SAE via endovenosa antes que pasen 2 horas del accidente. j) El antiveneno (butantan) resulta eficaz dentro de las 36 horas de producido el accidente. k) Administrar adrenalina intramuscular. l) Administrar suero anti-lactrodectus.

II. Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es verdadero y F si es Falso.

1. La dermatitis atópica es una enfermedad alérgica **FALSO**. El origen de la dermatitis atópica es multifactorial con un componente inmunológico y alteración de la función de la barrera cutánea que puede llevar a una sensibilización frente a determinados alérgenos. Pero no en todos los casos está presente esta sensibilización.
2. La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recidivante **Verdadero**.
3. Se considera que la dermatitis atópica es una enfermedad sistémica porque está asociada a procesos extracutáneos **Verdadero**.
4. La incidencia de la enfermedad varía según la etnia de la población y las condiciones del ambiente **Verdadero**.
5. Se ha publicado recientemente que la prevalencia de dermatitis atópica severa, en niños entre 6 y 11 años, es del 8% aproximadamente **Verdadero**.
6. En todos los casos la enfermedad comienza en los primeros años de vida **FALSO**. Algunos individuos desarrollan la enfermedad recién en la vida adulta.
7. Los objetivos del tratamiento de la dermatitis atópica es reducir el prurito y restablecer la función de la barrera cutánea **Verdadero**.
8. Para restablecer la función de barrera cutánea se debe evitar el uso de cremas corporales **FALSO**. El uso de emolientes y humectantes después del baño es fundamental para restaurar y conservar la función de barrera de la piel.
9. El diagnóstico de la enfermedad se basa fundamentalmente en los antecedentes familiares **FALSO**. El diagnóstico se basa en el prurito, la morfología y distribución de las lesiones, historia personal o familiar de atopía.
10. Además de las alteraciones genética que dan lugar a la alteración de la función inmune y de barrera cutánea, es necesaria la presencia de desencadenantes que favorezcan la aparición de la enfermedad **Verdadero**.

III. Ciertas condiciones actúan como “gatillos” que desencadenan la enfermedad . Mencione por lo menos 3 “gatillos.”

Ácaros, polvo, polen, ciertos alimentos, fibras sintéticas, prendas de lana, luz solar, infecciones, temperaturas extremas.

IV. Utilice las siguientes palabras para completar las oraciones para que sean afirmaciones correctas. Cada palabra puede ser usada una, varias o ninguna vez.

artritis – articulaciones- aumenta -codos – corticosteroides tópicos - cuero cabelludo- dendríticas- depresión- dermatitis atópica - diferenciación- disminuye- eczema- eritematoescamosas-estreptocócica- gatillos- genética. 8-10 años- inmunomoduladores- mutaciones - ombligo- palmas – plantas- plateado – retinoides- retroauricular- rodillas - vitíligo- sistémicos- 3- 5 años-

1. Las lesiones de psoriasis a menudo se confunden con las del **eczema** porque ambos son enfermedades crónicas que presentan piel enrojecida y escamosa.

2. La edad promedio de aparición de psoriasis es entre los **8 y 11 años**
3. La prevalencia de psoriasis **aumenta** con la edad.
4. En la enfermedad psoriasis, existe una predisposición genética, dada por la presencia de **mutaciones** en diversos genes, y acción de factores desencadenantes o gatillos.
5. Las células involucradas son los linfocitos T helper, las células **dendríticas** y natural killer (NK).
6. Las interleuquinas (IL) sintetizadas por las células dendríticas van a determinar la **diferenciación** de los linfocitos T vírgenes a T helper (Th) y la consecuente producción de diversas interleuquinas.
7. La faringitis **estreptocócica** se ha relacionado con la aparición y el empeoramiento de la psoriasis.
8. La brusca suspensión de corticoides **sistémicos** pueden gatillar la enfermedad.
9. Los hallazgos cutáneos clásicos en la psoriasis son placas eritematoescamosas con escamas de color blanco **plateado** que afectan con mayor frecuencia las rodillas, los codos, el cuero cabelludo, la zona posterior de los pabellones auriculares, el **ombligo** y la cara.
10. El compromiso del área retroauricular y del **ombligo** aumentan la sospecha de esta enfermedad.
11. Las lesiones clásicas de la enfermedad son placas **eritematoescamosas** claramente circunscritas.
12. El diagnóstico diferencial por excelencia es la **dermatitis atópica** en la que el eczema suele ser más prominente en las fosas antecubital y poplítea, áreas flexoras de las muñecas y las caras dorsales de las manos, mientras que las lesiones de psoriasis comúnmente se localizan en el **cuero cabelludo**, las **palmas**, las **plantas** y las superficies extensoras de los **codos** y las **rodillas**.
13. La psoriasis también puede coexistir con **vitiligo**, alopecia areata y liquen plano, lo que complica aún más el diagnóstico y tratamiento.
14. En el 80% de los niños con **artritis** psoriásica, la inflamación de las **articulaciones** se desarrolla entre 2 y 3 años antes de la aparición de la enfermedad de la piel.
15. El riesgo de desarrollar **depresión** después del inicio de la psoriasis es mayor que el de los niños sin la enfermedad.
16. Los **corticosteroides tópicos** se utilizan como primera línea para niños con psoriasis leve a moderada.
17. Para pacientes con una respuesta inadecuada a los tratamientos tópicos o con comorbilidades adicionales se pueden utilizar agentes **inmunomoduladores** orales o **retinoides** sistémicos.